

图 44-11　经皮经肝胆囊穿刺引流术

(1)穿刺针穿刺胆囊　(2)取出穿刺针内芯　(3)置入导丝　(4)拔除套管　(5)扩张管扩张皮肤穿刺口　(6)沿导丝置入引流导管,拔除导丝后固定导管于穿刺口旁皮肤

一般:胆系疾病女性多见

（二）急性非结石性胆囊炎（特殊）

导致胆囊壁缺血坏死

①机制：70%伴动脉粥样硬化（好发于**老年男性**），长期**肠外营养**（胃肠道长期缺乏食物刺激发生废用性萎缩 缺乏缩胆囊素刺激,导致胆汁长期淤积）

②表现类似急性结石性胆囊炎，但病情发展快、坏疽穿孔发生率高、应及早诊断和手术治疗

③检查：B 超（早期不易诊断）→肝胆系统**核素**扫描、CT 利于早期诊断　同急性结石性胆囊炎

面对急性非结石性胆囊炎、AOSC,CT的最佳体现在快,MRI的最佳体现在全面

Graves病女性多见,甲亢的周期性瘫痪男性多见
风湿系统疾病女性多见,强直性脊柱炎男性多见
类风湿关节炎多见于女性,类风湿结节男性多见

四、胆囊息肉和胆囊癌

（一）胆囊息肉

1.分类

①肿瘤性息肉：腺瘤（癌前病变）、血管瘤、脂肪瘤、平滑肌瘤、神经纤维瘤（最后一个字是瘤）

②非肿瘤性息肉：胆固醇息肉（几乎不癌变）、炎性息肉（几乎不癌变）、腺肌增生、腺瘤样增生、黄色肉芽肿、异位胃黏膜或胰腺组织

胆固醇结晶　多克隆

甲状腺有一个结节→单发结节偏恶性
乳房有一个肿块→单发肿块偏恶性

2.**胆囊息肉癌变的危险因素**：≥1cm（对比：≥2cm 的结石易癌变）、单发且基底部宽大、逐渐增大、合并胆囊结石和胆囊壁增厚特别是≥60 岁　同时有胆囊息肉和结石时,结石会与息肉摩擦刺激息肉

3.治疗

①无胆囊息肉癌变的危险因素+无临床表现：每 6-12 个月 B 超随访观察

②否则腹腔镜胆囊切除术：术中快速切片病检→若发现恶变再根据情况决定是否行肝切除及淋巴结清扫范围

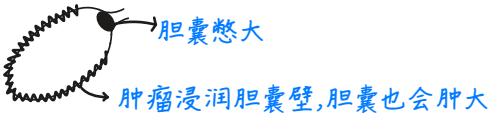
（二）胆囊癌

①好发于胆囊底、体部（DT in the house）（对比：穿孔好发于胆囊底、颈部）

②主要是腺癌

《病理学》：食管癌主要是鳞癌（Barrett 食管是腺癌）、肝癌主要是肝细胞癌、阑尾癌主要是类癌、胃癌/肠癌/胰腺癌/胆囊癌/胆管癌主要是腺癌

③可触及肿大胆囊、多为晚期（与肿瘤大小、长哪、是否梗阻有关）



④若不伴感染无发热，若不伴胆管梗阻无黄疸、无转氨酶升高（隐匿）

肝胆系统中没有转氨酶升高考虑:胆囊癌(没有胆管梗阻)、肝血管瘤

⑤手术